

Cancer du sein

Introduction:

Épidémiologie Mondiale :

- Le cancer (Kc) du sein est le cancer gynécologique le plus fréquent et le **premier Kc dans le monde**.
- C'est un problème majeur de santé dans le monde : **> 1,5 millions de nouveaux cas par an** et **> 500 000 décès par an**.

Épidémiologie au Maroc :

- C'est le **1er Kc de la femme** : il constitue **36%** de tous les cancers.

Disparités géographiques :

- L'incidence est **5 à 10 fois plus élevée** dans les pays industrialisés par rapport aux pays sous-développés.
=> L'importance capitale des facteurs environnementaux (alimentation, sédentarité, reproduction)
L'occidentalisation amène souvent obésité et puberté précoce ...

Diagnostic et Pronostic :

- La diminution de la mortalité passe par un **diagnostic précoce** (auto-examen, dépistage).
- Le diagnostic repose sur le **trépied : clinique, imagerie (mammographie et écho mammaire) et histologie**.

Facteurs de risque:

Facteurs génétiques : ATCD familiaux de Kc du sein

- **5-10%** des Kc du sein sont dus à une anomalie génétique : **Mutation du gène BRCA1 ou BRCA2**.
- Le **Risque Relatif (RR) est majoré** en cas de :
 - Existence de Kc du sein chez **un apparenté de 1er degré** (mère, sœur, fille).
 - Age de l'apparenté est **< 50 ans**.
 - **Pas de risque si l'âge > 75 ans** (considéré comme sporadique).
 - → Intérêt de faire une recherche de la mutation du gène BRCA1, BRCA2.
- **Arguments en faveur d'une mutation génétique délétère :**
 - ATCDs familiaux de cancer du sein (jeune âge de survenue, bilatéralité, multifocalité, parenté de premier degré).
 - D'autres cancers (ovaire +++).

Âge

- C'est le **facteur le plus important**.
- Le Kc du sein est **rare avant 30 ans**, le risque augmente **à partir de 40 ans**, et la fréquence maximale est entre **50 et 70 ans**.

Facteurs hormonaux endogènes

- **L'œstrogène a un rôle mitogène** = Plus les cellules se divisent, plus le risque d'erreur de copie de l'ADN (mutation) augmente.
- En cas d'**exposition prolongée aux œstrogènes endogènes** → c'est un facteur de risque important chez la **femme obèse ménopausée**.
 - **Ménarche précoce** : règles avant 12 ans ("règle après 14 ans ? => facteur protecteur").
 - **Ménopause tardive** : chaque année supplémentaire augmente le risque de **3%**.
 - **Obésité** : aromatisation des androgènes en œstrogènes dans le tissu adipeux.
 - Nulliparité
 - Age de la première grossesse tardif

- En cas de **suppression de l'exposition prolongée** aux œstrogènes endogènes → C'est un **facteur protecteur** :
 - **Parité +++** : c'est **LE** facteur le plus important. L'effet protecteur augmente avec le nombre de grossesses **menées à terme** et l'âge de la 1ère grossesse:
 - Une grossesse < **30 ans** diminue le risque de **25%**.
 - Avant **20 ans** diminue le risque de **30%**.
 - Après **35 ans** serait un FDR.
 - **Allaitement maternel** : serait un facteur protecteur s'il est **prolongé > 12 mois**. Plus la durée est longue plus l'effet protecteur est important (l'effet est plus important chez la femme jeune).
 - **Activité physique** : 30-60 min d'activité 4 fois par semaine diminue le risque de **30%** chez la femme ménopausée.

Facteurs hormonaux exogènes

■ Traitement hormonal de la ménopause (THM) / Substitutif (THS)

- Le risque augmente si le TRT **dépasse 5 ans**, le risque existe **pendant le traitement** et les **5 années qui suivent** l'arrêt.
- **MAIS** :
 - **Oestrogènes seuls** : **RR = 1,3**
 - **Oestrogène + progestérone** : **RR = 2**
 - ***Remarque:** L'association est plus risquée car la progestérone (ou progestatifs de synthèse) stimule aussi la prolifération cellulaire mammaire, contrairement à son effet protecteur sur l'endomètre.*

■ Contraception oestro-progestative

- Le risque existe mais **très faible (RR=1,2)**, surtout en cas d'**utilisation précoce (<20 ans)**.
- Le risque existe **au cours de l'utilisation et ne s'efface qu'après 10 ans**.
- Le Kc du sein diagnostiqué sous contraception est aux stades de début (Probablement par un meilleur dépistage).
- **Cependant la balance bénéfice / risque est pour la contraception** :
 - Mortalité maternelle diminuée.
 - Protection contre les autres cancers (diminution de la moitié des Kc de l'ovaire, colon, endomètre...).

FDR mammaires

■ Pathologies bénignes et hyperplasies:

- **N'augmente pas le risque (RR=0)** : Kyste mammaire, Cicatrice radiaire, Adénofibrome, Hyperplasie sans atypies.
- **Augmente faiblement (RR = 1,5-2)** : Mastopathie proliférante sans atypies, Adénose sclérosante, Papillome intra-canaulaire...
- **Augmente modérément (RR = 4-5)** : **Hyperplasie atypique canalaire, Hyperplasie atypique lobulaire.**
- **Augmente fortement (RR = 8-10)** : Carcinome canalaire in situ, Carcinome lobulaire in situ.

Mastopathies bénignes proliférantes avec atypies (exp: hyperplasie canalaire atypique) +++, Risque majoré si :

- Préménopause + ATCD familial de cancer du sein.
- RR 5,9 si hyperplasie atypique en préménopause.
- RR 7,3 si hyperplasie atypique + ATCD familial du cancer invasif.

■ Densité mammaire

- La relation entre densité du sein et cancer est établie.
- Un **sein dense** est le reflet de la stimulation **excessive et prolongée par les œstrogènes**.
- Il peut **masquer une lésion mammaire** à la mammographie.
- → Nécessité d'examens plus chers (**IRM**).

Autres FDR

- **Alimentation** : rôle mal connu, mais on retrouve :
 - Aliments **protecteurs** : légumes, phyto-œstrogènes, vitamines, oligoéléments...
 - Aliments **à risque** : graisses animales, alcool (augmente le taux circulant d'œstrogène), cigarette ?
- **Radiations ionisantes.**
- **Composés chimiques toxiques** (plastique, DDT : insecticide, herbicide, pesticide).

Anatomopathologie:

- **ADK (Adénocarcinome) = 98% des Kc du sein.**
- **Carcinome in situ** : non invasif et non infiltrant. 2 types:
 - **Canalaire**: à partir des canaux galactophores.
 - **Lobulaire**: à partir des lobules (groupes de glandes) qui produisent le lait.
- **Carcinome infiltrant** : invasif et infiltrant. Plusieurs types :
 - **Canalaire** (carcinome galactophorique).
 - **Lobulaire** (carcinome glandulaire).
 - **Autres** : Maladie de Paget (atteinte du mamelon), Comédocarcinome, carcinome médullaire, colloïde, tubuleux, papillaire...
- **Sarcomes (< 2%)** : Ce sont des tumeurs du tissu conjonctif :
 - Sarcomes phyllodes.
 - Sarcomes du stroma primitif : angiosarcome, fibrosarcome, liposarcome...
- **Métastases** : Les tumeurs secondaires mammaires (venant d'ailleurs) sont exceptionnelles.

Mode d'Extension:

- **Extension locale** : se fait de proche en proche par voie galactophorique.
- **Extension lymphatique** : se fait au niveau des **GG axillaires** (extension de bas en haut) et des **GG de la chaîne mammaire interne** (et sus-claviculaire).
- **Extension hématogène** : se fait vers l'**os, le poumon, le foie, et le cerveau.**

Diagnostic positif:

Il se fait lors de **dépistage de masse**, du **dépistage spontané** (auto palpation), de l'**examen systématique** ou lors de la découverte d'une **anomalie mammaire**.

Clinique:

- Le sein est un organe accessible à l'examen.
- Dans **70% des cas**, c'est la patiente elle-même qui découvre la tumeur d'une **façon fortuite** lors d'une **autopalpation**.

Interrogatoire

- **Motif de consultation** :
 - **Tumeur (65-80%)** : date de début ? Vitesse de croissance tumorale.
 - **Douleur = mastodynies (15%)** En général, le cancer est indolore.
 - **Modification cutanée (5-7%)**.
 - **Écoulement mamelonnaire (2-10%)** : unilatéral, unipore, séro-sanglant.
 - **ADP axillaire** (Adénopathie).
 - **Gros bras** (Lymphœdème).
- ATCD personnels et familiaux, FDR.
- Mode d'installation et évolution.

Examen clinique

Torse nu, bonne lumière, comparatif, bras ballants puis relevés.

Inspection :

- Modification des contours des seins, Asymétrie des 2 seins ou des 2 mamelons.
- **Signes inflammatoires** : rougeur, **peau d'orange** (signe d'œdème lymphatique).
- **Modification cutanée** : rétraction, dépression, ulcération...
- **Mamelon** : Ombilication (rétraction vers l'intérieur), aspect eczématiforme.
- **Écoulement (20-40%)** : suspect si **unilatéral, unipore, sanglant ou séro-sanglant**.
 - Écoulement séreux (RR 15%).
 - Écoulement unipore sanglant (RR 25%).
 - Écoulement lactescent ou verdâtre (RR 0% - bénin).
 - Lactescent → Infection du lait ou abcès.
 - Verdâtre → Infection.

Palpation :

- **La tumeur** :
 - **Siège** : Plus au niveau du sein gauche, au **QSE** (Quadrant Supéro-Externe >38%) ou en retro-mamelonnaire (29%).
 - **Taille** : Mesurer le plus grand diamètre. Si multifocale, prendre la plus grande.
 - **Limites** : Tumeurs malignes souvent mal limitées.
 - **Consistance** : Dure, parfois molle (cancer médullaire, colloïde).
 - **Mobilité** : par rapport au plan superficiel et profond (signe d'envahissement).
 - **Multifocalité** : Multifocale (même quadrant) vs Multicentrique (quadrants différents) vs Bilatéralité.
 - **Signes inflammatoires (Triade)** : Chaleur, rougeur, douleur → Tumeur à croissance rapide.
 - **Mamelon** : Recherche d'écoulement (pression douce).
- **Les aires GG (Ganglionnaires)** :
 - Examen systématique axillaire et sus-claviculaire des 2 côtés.
 - Suspectes si : **dure, homolatérale, fixée ou sensible**.

Examen général:

A la recherche de métastases : Pleuro-pulmonaires, Hépatiques, Osseuses (Points douloureux)

Radiologie: couple Echo-Mammo

Interêt de l'imagerie:

- Localise la lésion
- Guide la biopsie
- Localises d'autres lésions associées
- Identifie les lésions qui ne nécessitent pas de lésions

Mammographie (Face et oblique 3/4)

Indication : **1ère intention** sauf femme enceinte/allaitante ou jeune fille (< 30 ans).

Technique : Entre J8 et J10 du cycle (sein moins congestif, moins douloureux).

Incidences : Face, Profil, Oblique externe (+/- clichés centrés/agrandis).

Dépistage : Détecte les tumeurs infracliniques.

Sémiologie radiologique: Lésions élémentaires

- **Opacité : Forme, contours, densité**
 - Stellaire, Spiculée (en "étoile"), à centre dense.
 - Contours irréguliers.
 - Prolongements opaques linéaires.
 - Topographies canalaire: triangulaire à sommet retro-mamelonnaire.

- Taille radiologique est généralement inférieure à la Taille palpée (signe important de malignité dû à la réaction stromale œdémateuse autour qui est palpable mais radiotransparente,).

- **Microcalcifications:**

- Isolées ou associées à l'opacité.
- Vermiculaires, en bâtonnet, irrégulières.
- Groupées en amas.
- Classification des microcalcifications:
 - Type 1 : annulaires, arciformes ou polyédriques.
 - Type 2 : rondes.
 - Type 3 : poussiéreuses pulvérulentes.
 - Type 4 : irrégulières
 - **Type 5 +++ : vermiculaires ou branchées ou canalaire.**

- **Signes indirects :** Désorganisation architecturale, rétraction, épaissement cutané.

- Autres signes non typiques :
 - Opacité ronde
 - Opacité microlobulée
 - Micro calcifications poussiéreuse ou punctiformes ou encore rondes, régulières
 - Hyperdensité mal systématisée surtout à limites convexes ...

- **Classification ACR (American College of Radiology) :**

- **ACR 0 :** Classification d'attente (investigations nécessaires).
- **ACR 1 :** Normale. **VPP=0%**. Ne rien faire.
- **ACR 2 :** Anomalies bénignes sans gravité. **VPP=0%**. Pas de surveillance.
- **ACR 3 :** Anomalie probablement bénigne. **VPP <5%**. Surveillance à court terme (3 ou 6 mois) conseillée.
- **ACR 4 :** Anomalie indéterminée ou suspecte. **VPP 5-70%**. **Biopsie.**
- **ACR 5 :** Anomalie évocatrice d'un Kc (Opacité mal limitée, spicules, microcalcifications vermiculaires ou branchées ou canalaire). **VPP >70%**. **Biopsie.**

Échographie mammaire

- Faite en complément de la mammo, mais de **première intention si** : Femme jeune <25 ans / Enceinte / Allaitante / Suspicion d'abcès / Complications post-op, seins denses.
- Permet une bonne exploration des **seins denses**.
- **Limite** : n'explore pas les micro-calcifications.
- Permet de classer ACR grâce à l'échostructure.
- **Signes de malignité** :
 - Image Hypoéchogène hétérogène.
 - Contours irréguliers (anguleux, microlobulés, spiculés).
 - **Atténuation des faisceaux postérieurs** (cône d'ombre).
 - **Grand axe perpendiculaire à la peau** (plus haut que large).
 - Présence d'ADP axillaires suspects.

Autres examens

- **IRM mammaire** : Indications limitées : Surveillance seins traités, seins opaques/denses, discordance radio-clinique (echo-mammo insuffisantes), bilan d'extension (pour un TTT conservateur), Désorganisation architecturale, surveillance de cancer génétique. Grande valeur prédictive négative
- **Écho-doppler** : Étudie la vascularisation (intérêt pour seins traités) => pas pour le dgc.
- **Galactographie rétrograde** : Si écoulement sans masse palpable.

Examens anatomopathologiques:

Histologie (Confirmation)

- **Micro-biopsie (biopsie au tru-cut):** Examen simple, coût faible, sous contrôle écho ou clinique.
- **Macro-biopsie :** (Ex: Mammotome) Si microcalcifications.
- Examen extemporané si discordance clinique radio (pour décision per-op = curage).
- **Repérage stéréotaxique :** Pour lésions infra-cliniques.
- Biopsie chirurgicale
- Parfois sur pièce: Tumorectomie / pyramidectomie (si galactorragie)
- **Récapitulatif :**
 - Lésion infra-clinique : microbiopsie/exérèse sous repérage.
 - Lésion palpable : microbiopsie +++.
- **Intérêts : QE**
 - **Type histologique** de la tumeur
 - **Caractère infiltrant** ou non de la tumeur
 - Le **grade histologique** de la tumeur
 - La recherche des **récepteurs hormonaux**

Examen cytologique: Cytoponction:

- On peut faire une cytoponction sur:
 - Nodule
 - Adénopathie axillaire ou sus claviculaire palpable.
 - Liquide d'écoulement mamelonnaire
 - Grattage cutanée si maladie de paget
 - Ponction à l'aiguille fin
- Renseigne sur présence ou non cellules malignes
- Cytoponction n'a de valeur que si positive, une cytologie négative n'élimine pas dg cancer.
=> Toujours la confronter aux examens clinique et radiologique (Peu de place actuellement).

Marqueurs tumoraux (CA 15-3)

- **Aucun intérêt dans le diagnostic ni le dépistage.**
- Intérêt dans le **suivi post-traitement**. Dosage AVANT le début du traitement.
- Taux très élevé = stade métastatique (dans 90-97% des cas).

Bilan d'extension:

- Fonction de la clinique et facteurs pronostics : Rx thorax, écho hépatique, scinti osseuse, TDM TAP, TDM cérébral...

Classification:

TNM:

- **T (Tumeur) :**
 - **T x :** Détermination de la tumeur primitive est impossible.
 - **T 0 :** Pas de signe de tumeur.
 - **T is :** Carcinome in situ : (CLIS, CCIS , Maladie de Paget sans tumeur palpable).
 - **T1 : $\leq 2\text{cm}$** ($T1_{mic} \leq 0,1\text{cm}$; $T1a \leq 0,5\text{cm}$; $T1b \leq 1\text{cm}$; $T1c > 1-2\text{cm}$). Non ou difficilement palpable.
 - **T2 : $> 2-5\text{cm}$.**
 - **T3 : $> 5\text{cm}$.**
 - **T4 : Toute taille avec extension.**
 - T4a : Paroi thoracique (fixe sur le plan profond)
 - T4b : Peau (ulcération, nodules, fixe sur le plan superficiel).
 - T4c : Les deux (a+b).
 - **T4d : Cancer inflammatoire.**

- **N (Adénopathies) :**
 - **N0** : Pas de GG.
 - **N1** : ADP axillaires homolatérales **mobiles**.
 - **N2** : Ganglions axillaires homolatéraux **fixes** entre eux ou à d'autres structures.
 - **N3** : Ganglions sous et sus claviculaires
- **M (Métastases) :** M0 (absent) / M1 (présent).

Classification PEV (Poussée Évolutive) : à oublier

- **PEV 0** : Pas de signes évolutifs.
- **PEV 1** : Tumeur double de volume en 6 mois.
- **PEV 2** : Signes inflammatoires localisés (œdème/rougeur) en regard tumeur.
- **PEV 3** : Inflammation diffuse à tout le sein (**Mastite carcinomateuse**).

Classification moléculaire:

Selon les récepteurs oestrogène et progestérone, récepteur HER2 et le Ki67 (marqueur de prolifération cellulaire).

- **Luminal A** : RE+, RP+, HER2-, **Ki67 bas. Bon pronostic** (Grade I-II).
- **Luminal B** : RE+, RP+, HER2-, **Ki67 haut** (>15-20%).
- **Basal (Triple Négatif)** : RE-, RP-, HER2-. Souvent Grade III.
Plus fréquent si mutation BRCA1. Très agressif.
- **Basal like (HER2+)** : RE-, RP-, HER2+.

Diagnostic différentiel:

Les tumeurs bénignes:

Adénofibrome:

Plus fréquentes

Clinique : caractéristiques bénignité

Tumeur arrondie , ovoïde , mobile, ferme

Sans adénopathies axillaires

Tumeurs phyllodes :

Clinique : Tumeurs volumineuses , ovalaires à croissance rapide , parfois polylobée, de consistance molle.

Mammographie + échographie mammaire : Aspect polycyclique , à contours réguliers et bien limités.

Risque de formes sarcomateuses +++ (car 3 grades: I bénin, II borderline, III sarcome).

Dystrophie fibrokystique du sein :

Terrain d'hyperoestrogénie

Clinique : Mastodynies, Seins durs, avec des masses palpables, sensibles, consistance élastique et d'aspect kystique.

Intérêt radiologie et parfois histologie

Tuberculose mammaire:

Localisation primaire ou secondaire

Clinique : Tumeur mal limitée, abcès froid

Radiologie : Aspect d'allure maligne (mime ACR 5).

Histologie : +++

Abcès du sein:

Surtout en cas de cancer inflammatoire d'où l'intérêt de biopsie après drainage d'un abcès

Pronostic:

Survie globale

- Estimée à **50% à 5 ans** (moyenne globale).

- Stade 0 et 1 : 100%.
- Stade 4 (métastatique) à 5ans : < 15%.
- **Mauvais pronostic** : Femme jeune, Femme enceinte et allaitante.

Facteurs pronostics

- **Taille tumorale** : Petite (T1) = meilleur pronostic. Associée au statut ganglionnaire, permet de prédire de façon relativement précise la survie à 5 ans.
- **Statut GG (Ganglionnaire)** : Nombre de GG positifs est un facteur de mauvais pronostic (surtout si > 3), rupture capsulaire, envahissement sus-claviculaire.
 - < 0.5 avec N- → 99% survie
 - < 0.5cm et plus de trois N+ → 59%
- **Grading histo-pronostic SBR (Scarff-Bloom-Richardson)** : Il prend en compte la différenciation, la morphologie nucléaire, la richesse en mitoses
Grade I (bon), Grade III (mauvais avec Métastases rapides).
- **Récepteurs hormonaux (RH)** :
 - **RE** (Récepteurs Oestrogènes) et **RP** (Progestérone).
 - S'ils sont présents (+), c'est de **bon pronostic** (indice de bonne réponse à l'hormonothérapie).
- **Facteur de prolifération** : ki67
- **Surexpression HER2** :
 - Récepteur membranaire des facteurs de croissance.
 - 15-20% des Kc du sein.
 - Facteur de **mauvais pronostic** (3x plus de risque métastatique viscéral).
 - Facteur prédictif de réponse à l'Herceptin (trastuzumab) anticorps monoclonal anti-HER2
 - 7- biologie molécule
- **Âge** : Femme ménopausée (bon pronostic) vs Femme jeune (mauvais prono).
- Autres: TNM ...

Traitement:

Méthodes

Chirurgie :

Conservatrice :

Traitement conservateur de la glande mammaire tout en enlevant la tumeur avec des marges de sécurité. Tumorectomie large

- Tumorectomie large: Exérèse de la tumeur avec une marge de tissu sain péri-tumoral
- Quadrantectomie: Ablation d'un quadrant entier du sein
- Pyramidectomie: consiste à enlever une zone en forme de pyramide autour d'un canal lactifère
- + curage axillaire (ou ganglion sentinelle).

Ganglion sentinelle:

1er ganglion atteint

- **Deux méthodes**: Colorimétriques et Isotopes
- **Si négatif** : pas de curage, ce qui permet d'éviter les complications du curage
- Mais **indications précises**: Petite tumeur, Pas d'adénopathies clinique

Radicale :

- **Mastectomie Totale (ou Simple)**: Exérèse de l'ensemble de la glande mammaire, de la plaque aréolo-mamelonnaire (PAM) et d'une ellipse de peau.
- **Patey**: Mastectomie radicale + curage gg (elle a remplacé la technique de Halsted qui retire en plus les muscles pectoraux).
- **Mastectomie de propreté**: pour soulager des symptômes locaux très avancés et handicapants.

- **Les Mastectomies avec Conservation de l'Enveloppe (Skin-Sparing):** On retire la glande, mais on préserve l'étui cutané natif. Ce qui permet une Reconstruction Mammaire Immédiate.
Le choix entre reconstruction immédiate et différée est une décision prise en RCP.
- **Curage axillaire :** Intérêt pronostique mais risques:
 - Le risque à court terme : abcès, lymphocèle, douleurs post-op...
 - Le risque à long terme : gêne fonctionnelle, lymphœdème
 - → **Ganglion Sentinelle** : Technique pour éviter le curage complet si le 1er relais ganglionnaire est sain.

Radiothérapie :

- **Intérêt : Éviter les récurrences locales +++++**
- **en complément avec la chirurgie**
- Complément **indispensable** au traitement conservateur pour éviter les récurrences locales.
- Radiothérapie externe (pas de curiethérapie):
 - Sein ou paroi thoracique ou le lit tumoral
 - Chaîne mammaire interne
 - Creux axillaire
 - Ganglions sus claviculaires.

Chimiothérapie :

- Adjuvante (après chirurgie) ou néo-adjuvante (avant, pour réduire la tumeur).
- Intérêt :
- Éviter les métastases chez les patientes à risque
- Stériliser les micro foyers métastatiques.

Hormonothérapie :

- Objectif : Bloquer l'action des œstrogènes. **Toujours adjuvante.**
- **Castration** : Chirurgicale ou radique ou Analogues LH-RH (femme non ménopausée).
- **Anti-aromatases** (Letrozole, Anastrozole) : Inhibent la production d'oestrogènes. Pour femme **ménopausée**. Risque : Ostéoporose.
- **Tamoxifène** : Bloque les récepteurs. Risque : Cancer de l'endomètre, thrombose, augmentation de la taille des fibromes, kyste fonctionnel de l'ovaire ...

Thérapie génique (Ciblée) :

- **Trastuzumab (Herceptine)** : Anticorps monoclonal contre **HER2**. Indiqué si surexpression HER2.

Indications (Synthèse):

Fonction de plusieurs facteurs:

- Classification TNM
- Traitement conservateur ou non
- Facteurs de prolifération
- Envahissement axillaire.
- Récepteurs hormonaux
- Surexpression HER2...
- **Tumeur < 3 cm (Si pas de préjudice esthétique = taille du bonnet):** Traitement conservateur + Radio + (Chimio/Hormono/Herceptin selon profil).
Préjudice esthétique: même si la tumeur est petite, une patiente avec un bonnet A => c'est difficile de faire un traitement conservateur.
- **Tumeur > 3 cm** : PATEY (Mastectomie) + Radio + Chimio/Hormono...
- **Tumeur inflammatoire ou locale avancée (T4d/PEV)** : Chimio **Néo-adjuvante** d'abord → puis PATEY + Radio...
- **Métastatique** : Chimio PALLIATIVE +/- Hormono +/- Herceptin.

- **Sarcome** : Mastectomie simple.
- **Lymphome** : chimiothérapie

Chimiothérapie en adjuvant:

- N+
- N – mais présence de facteurs de
 - Age < 35 ans
 - RE – et RP –
 - SBR II ou III
 - EV +
 - HER2+++
 - Taille >2 cm...

Chimiothérapie Néoadjuvante:

- Tumeur localement avancés et inflammatoire T4
- Suivie de chirurgie conservatrice après
- Tumeur < 2cm triple négative, herceptine ou luminal B....

Surveillance:

Doit être régulière :

- **Clinique** : Tous les 3 mois la 1ère année, puis tous les 6 mois, puis 1 fois/an à partir de 5 ans.
- **Radiologique** : Mammo +/- Écho mammaire (annuelle).
- **Biologique** : CA 15-3 tous les 6 mois.

Formes particulières: impasse

Cancer du sein chez la femme enceinte ou allaitante:

1 à 3 % des cancers du sein.

Diagnostic clinique : DIFFICILE.

Diagnostic radiologique ?

Retard diagnostic ++++

Problème de prise en charge.

Cancer du sein chez l'homme:

Très rare : 0,5 % des cancers du sein.

Age : 60 – 65 ans.

Clinique : Tumeur à caractères de malignité

Évolution : Plus rapide que chez la femme.

Pronostic : très sévère.